



Trauma, cuidados paliativos y depresión infantojuvenil: claves clínicas del 2 de junio de 2026

MARTES 2 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad publicó la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026–2030, aprobada por el CISNS en abril, que reconoce por primera vez de forma explícita la atención psicológica como componente esencial en estos equipos. Desde Nature Reviews Psychology, una revisión de Engelhard et al. propone ampliar el concepto de trauma psicológico más allá de los criterios objetivos del DSM, con implicaciones directas para la práctica clínica. Un estudio en European Child & Adolescent Psychiatry cifra en el 14% la proporción de adolescentes españoles con síntomas clínicamente significativos de al menos un trastorno internalizante, con depresión, TOC y problemas alimentarios al frente. Estas tres líneas apuntan a un momento de actualización conceptual y normativa relevante para la psicología clínica y la neuropsicología.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

La estrategia de cuidados paliativos 2026–2030 incorpora la atención psicológica como componente esencial

El Ministerio de Sanidad ha publicado el documento 2026–2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos, aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) en abril de 2026. El nuevo marco redefine quién

necesita cuidados paliativos: ya no se basa solo en el pronóstico terminal, sino en el sufrimiento causado por la enfermedad, lo que amplía sustancialmente la población diana. El 75% de las muertes en España están relacionadas con enfermedades crónicas con necesidades paliativas; de ese porcentaje, el 50% corresponde a patologías no oncológicas como demencias, insuficiencias orgánicas o fragilidad avanzada. La estrategia establece explícitamente que el abordaje psicológico es un componente esencial y fija el Objetivo 2.7, orientado a garantizar el acceso a atención psicológica para pacientes y familiares, incluyendo cribados sistemáticos de malestar psicológico con herramientas validadas e integración en la historia clínica electrónica. Sin embargo, advierte de que varias comunidades autónomas siguen sin contar con psicólogo en sus equipos de cuidados paliativos. El documento establece un modelo escalonado de atención psicológica con cuatro niveles de especialización, en línea con el modelo NICE, y recomienda una dotación orientativa de un profesional de la psicología por cada 35 camas en las unidades específicas.

CLÍNICA · NACIONAL

Revisar el concepto de trauma psicológico puede mejorar el acceso a la atención clínica

Una revisión publicada en *Nature Reviews Psychology* (Engelhard et al., 2026) plantea que la definición actual de trauma psicológico del DSM —centrada en características objetivas como muerte, lesiones graves o violencia sexual— deja fuera a personas con síntomas postraumáticos clínicamente significativos cuya experiencia no encaja en esos criterios. Los autores señalan que el riesgo condicional de TEPT tras cualquier acontecimiento traumático definido según DSM-IV es del 4%, pero que ese porcentaje se eleva sustancialmente ante violencia interpersonal (hasta el 20,9% en algunas muestras). El trabajo revisa evidencia sobre el papel de factores subjetivos —interpretación del acontecimiento, vulnerabilidad previa, contexto social, sexo y género femenino, bajos ingresos— y destaca que experiencias como la discriminación racial, el desahucio o el acoso pueden asociarse con síntomas postraumáticos en metaanálisis de 124 estudios, aunque no estén reconocidas como traumáticas por el DSM. Los autores advierten de la necesidad de no patologizar respuestas

emocionales normales y defienden una definición más integradora que guíe tanto el acceso al tratamiento como el diseño de estrategias preventivas.

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

El 14% de los adolescentes españoles presenta síntomas clínicamente significativos de al menos un trastorno internalizante

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, publicado en *European Child & Adolescent Psychiatry* en noviembre de 2025, analizó una muestra representativa de 5.450 niños y adolescentes españoles de 9 a 16 años. Los resultados muestran que el 10,4% de los niños y el 14% de los adolescentes presentan síntomas clínicamente significativos de al menos un trastorno internalizante. En niños, los más frecuentes son depresión (4,7%), ansiedad social (3,6%) y trastorno de ansiedad generalizada (3,4%); en adolescentes destacan el TOC (4,5%), los problemas de conducta alimentaria (4,3%) y la depresión (4,0%). Aunque algunas tasas han aumentado respecto a datos prepandémicos, los autores señalan que se mantienen por debajo de las registradas durante el COVID-19. Los patrones de comorbilidad revelan que la presencia de síntomas depresivos clínicamente significativos incrementa el riesgo de presentar simultáneamente TAG, TEPT y quejas somáticas. El estudio subraya la necesidad de reforzar los servicios de salud mental infanto-juvenil, promover la detección precoz e implementar intervenciones específicas en entornos sanitarios y educativos.

Publicaciones científicas recientes

Engelhard, I. M., Kryptos, A.-M., McNally, R. J., Mertens, G., & van Zuiden, M. (2026). Defining the concept of psychological trauma. *Nature Reviews Psychology*, 5, 327–337.

DOI: [10.1038/s44159-026-00557-y](https://doi.org/10.1038/s44159-026-00557-y)

Hallazgo: El TEPT no depende únicamente de las características objetivas del acontecimiento; factores subjetivos como la interpretación, la vulnerabilidad previa, el contexto social y las experiencias indirectas tienen un papel determinante. Acontecimientos no reconocidos por el DSM —discriminación, desahucio, acoso— pueden asociarse con síntomas postraumáticos según un metaanálisis de 124 estudios.

Implicación clínica: Ampliar el concepto clínico de trauma permite identificar y tratar pacientes que actualmente no acceden a intervención especializada. La evaluación debe incluir la experiencia subjetiva del acontecimiento, el historial de adversidad y los factores de vulnerabilidad individuales, sin restringirse a los criterios objetivos del diagnóstico formal.

Orgilés, M., Amorós-Reche, V., Morales, A., Marzo, J. C., Piqueras, J. A., & Espada, J. P. (2025). Depression, anxiety, and internalizing symptoms in Spanish children and adolescents: estimated rates and comorbidity patterns. *European Child & Adolescent Psychiatry*.

DOI: [10.1007/s00787-025-02916-1](https://doi.org/10.1007/s00787-025-02916-1)

Hallazgo: El 14% de los adolescentes y el 10,4% de los niños españoles presentan síntomas clínicamente significativos de al menos un trastorno internalizante. Los patrones de comorbilidad muestran que la presencia de síntomas depresivos aumenta el riesgo de trastornos asociados como TAG, TEPT y quejas somáticas.

Implicación clínica: La evaluación clínica en contextos pediátricos y educativos debe contemplar la comorbilidad internalizante de forma sistemática. Los datos respaldan el diseño de protocolos de detección precoz en atención primaria pediátrica y en entornos escolares.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Herramientas validadas de cribado de malestar psicológico en cuidados paliativos:** La Estrategia de Cuidados Paliativos 2026–2030 establece la incorporación de instrumentos de cribado de malestar psicológico y emocional validados en la historia clínica electrónica. Su uso sistemático permite detectar

precozmente necesidades de atención psicológica en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y en sus familias, y activar los niveles de intervención adecuados según el modelo escalonado de cuatro niveles propuesto.

– **Instrumentos de evaluación del trauma con enfoque biopsicosocial:** La revisión de Engelhard et al. subraya la necesidad de incorporar en la evaluación clínica instrumentos que vayan más allá de los criterios objetivos del DSM, contemplando la experiencia subjetiva del acontecimiento, el historial de adversidad acumulada, los factores de vulnerabilidad (género, nivel socioeconómico, historial previo de problemas psicológicos) y las experiencias de trauma indirecto o vicario.

Prioridades del día

Actualizar la práctica en trauma

La revisión de Engelhard et al. en *Nature Reviews Psychology* ofrece argumentos sólidos para revisar los protocolos de evaluación del TEPT en consulta. Incorporar la experiencia subjetiva, el trauma indirecto y los factores de vulnerabilidad permite identificar pacientes que actualmente quedan sin cobertura clínica. Es un momento oportuno para revisar los instrumentos de evaluación utilizados habitualmente.

Posicionarse en cuidados paliativos

La Estrategia 2026–2030 abre una oportunidad concreta para la psicología clínica y sanitaria: establece la necesidad de psicólogo en los equipos paliativos y fija una dotación de referencia. Para profesionales que trabajan con personas mayores, enfermedades crónicas avanzadas o duelo, es un marco normativo que respalda la demanda de servicios especializados.

Los datos del estudio de la UMH evidencian que casi uno de cada siete adolescentes españoles presenta síntomas clínicamente significativos de al

menos un trastorno internalizante. La alta comorbilidad entre depresión, TOC, problemas alimentarios y TAG en esta franja exige protocolos de cribado sistemático que incluyan instrumentos específicos para adolescentes.